2024-2025

UNIVERSITÉ Clermont Auvergne

UE 13 : Etat de santé et organisation



DETERMINANTS DE LA MORTALITE INFANTILE ET PERSPECTIVES DE PREVENTION : CAS DE LA COTE D'IVOIRE



Auteurs :

N'goran Ange-Ange KOUAME (M1 SP)

Ehouman Ange Paradis NAHA (M1 SP)

Kader Ali TRAORE (M1 ES)

Enseignant : **M. APPAIX Olivier**

SIGLES, ACRONYMES ET ABREVIATIONS

INSEE : Institut National de la Statistique et des Études Économiques

OMS : Organisation mondiale de la santé

ODD : Objectifs de développement durable

UNICEF : United Nations International Children's Emergency Fund (Fonds des Nations Unies pour l'enfance)

PNLP : Programme National de Lutte contre le Paludisme

CMU : Couverture Maladie Universelle

FCFA : Franc de la Communauté Financière Africaine

PNUD : Programme des Nations Unies pour le Développement

PEV : Programme Élargi de Vaccination

BAD : Banque Africaine de Développement

INS : Institut National de la Statistique

LISTE DES GRAPHIQUES

FIGURE 1 ÉVOLUTION HISTORIQUE ET TENDANCES DE LA MORTALITÉ INFANTILE EN CÔTE D'IVOIRE.....4
FIGURE 2 ANALYSE COMPARATIVE DES TAUX DE MORTALITÉ INFANTILE ENTRE LA CÔTE D'IVOIRE ET LE SÉNÉGAL.....7

LISTE DES TABLEAUX

TABLEAU 1 ANALYSE COMPARATIVE DES TAUX DE MORTALITÉ INFANTILE ENTRE LA CÔTE D'IVOIRE ET LE SÉNÉGAL.....8

Table des matières

SIGLES, ACRONYMES ET ABREVIATIONS..... 1
LISTE DES GRAPHIQUES..... 2
LISTE DES TABLEAUX..... 2
Table des matières..... 3
Introduction..... 3
I. Évaluation de l'état de santé infantile en Côte d'Ivoire..... 4
I.1 Indicateurs de mortalité infantile..... 4
I.2 Évolution historique et tendances récentes..... 4
II. Les systèmes de santé et leur impact sur la mortalité infantile..... 5
II.1 Structure et organisation du système de santé en Côte d'Ivoire..... 5
II.2 Accessibilité et qualité des soins pour les nourrissons..... 5
II.3 Programmes et politiques de santé publique visant à réduire la mortalité infantile..... 5
III. Déterminants de la mortalité infantile en Côte d'Ivoire..... 5
III.1 Facteurs médicaux et socio-économiques..... 6
III.2 Facteurs environnementaux et culturels..... 6
IV. Analyse économique de la mortalité infantile..... 6
IV.1 Impact économique de la mortalité infantile sur le développement du pays..... 6
IV.2 Coût des soins et financement des politiques de santé infantile..... 6
V. Comparaison avec le Sénégal et perspectives de prévention pour la Côte d'Ivoire..... 7
V.1 Analyse comparative des taux de mortalité infantile entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal..... 7
V.2 Politiques et stratégies mises en place au Sénégal pour réduire la mortalité infantile..... 8
V.3 Leçons applicables à la Côte d'Ivoire..... 8
Conclusion..... 8
BIBLIOGRAPHIE..... 10

Introduction

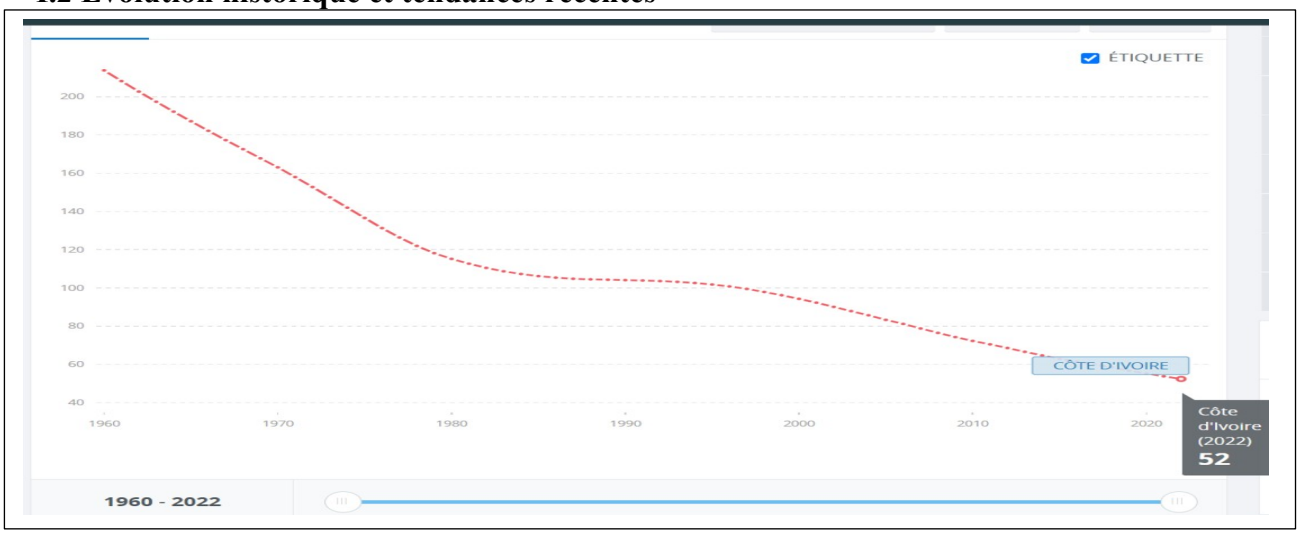
La mortalité infantile désigne le nombre d'enfants décédés avant leur premier anniversaire pour 1 000 naissances vivantes. Selon l'Institut National de la Statistique et des Études Économiques (INSEE), elle concerne spécifiquement les enfants nés vivants mais décédés avant l'âge d'un an (Définition - Mortalité infantile | Insee s. d.). En effet, elle reflète non seulement les conditions de vie des populations, mais aussi les inégalités d'accès aux soins de santé, à l'eau potable, à l'assainissement et à l'éducation. La Côte d'Ivoire, pays d'Afrique de l'Ouest comptant près de 30 millions d'habitants, n'échappe pas à cette réalité, malgré les efforts déployés par le gouvernement ivoirien et le soutien des institutions internationales. En 2022, le taux de mortalité infantile dans le pays s'élevait à 52 décès pour 1 000 naissances vivantes (Taux de mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes) - Cote d'Ivoire | Data s. d.), selon la Banque mondiale, un chiffre nettement supérieur à la moyenne mondiale. Ce taux élevé traduit des insuffisances persistantes du système de santé, notamment en matière d'accès aux soins prénataux, de couverture vaccinale et de mesures préventives contre des maladies endémiques telles que le paludisme. Sur le plan mondial, la mortalité infantile a enregistré une baisse significative ces dernières décennies. Selon les données de la Banque Mondiale (BM), le taux de mortalité infantile était de 28 décès pour 1 000 naissances vivantes en 2022. Toutefois, des disparités régionales persistent : en Afrique subsaharienne, ce taux atteint 72 décès pour 1 000 naissances vivantes, et en Afrique de l'Ouest, il est de 68 pour 1 000 naissances vivantes. L'étude de la mortalité infantile en Côte d'Ivoire est cruciale, car elle permet d'évaluer le niveau de développement socio-économique du pays ainsi que l'efficacité de son système de santé. Cette recherche vise à identifier les principaux déterminants de la mortalité infantile et à proposer des stratégies adaptées pour réduire ce phénomène. La diminution de la mortalité infantile est essentielle pour renforcer le capital humain, facteur clé de la croissance économique. Afin de mieux contextualiser la situation ivoirienne, une comparaison avec le Sénégal met en évidence des différences significatives. En 2023, le Sénégal affichait un taux de mortalité infantile de 28 décès pour 1 000 naissances vivantes (Banque mondiale, 2022). Cette comparaison souligne l'urgence d'identifier les facteurs spécifiques qui contribuent à la mortalité infantile en Côte d'Ivoire et d'explorer des solutions inspirées des meilleures pratiques régionales.

I. Évaluation de l'état de santé infantile en Côte d'Ivoire

I.1 Indicateurs de mortalité infantile

L'analyse des déterminants de la mortalité infantile en Côte d'Ivoire repose sur plusieurs indicateurs clés, étroitement liés aux spécificités socio-économiques et sanitaires du pays. Le taux de mortalité infantile reflète la qualité des soins de santé, les conditions sanitaires et la nutrition. Le taux de mortalité néonatale, qui se concentre sur les décès dans les 28 premiers jours de vie. Le taux de mortalité des moins de 5 ans offre une perspective globale sur les risques sanitaires auxquels les enfants ivoiriens sont exposés. L'accès aux soins prénataux est un facteur déterminant. La prévention du paludisme constitue un enjeu majeur, car cette maladie reste l'une des principales causes de morbidité infantile. La couverture vaccinale complète reste un indicateur crucial pour prévenir les maladies évitables. Enfin, les dépenses de santé en pourcentage du PIB illustrent l'engagement de l'État en faveur de la santé publique.

I.2 Évolution historique et tendances récentes



https://donnees.banquemondiale.org/indicateur/SP.DYN.IMRT.IN?contextual=default&end=2022&locations=CI&most_recent_year_desc=false&start=1960&view=chart

Historiquement, la Côte d'Ivoire a connu des progrès notables dans la réduction de la mortalité infantile, mais ces avancées ont été ralenties par des crises socio-politiques et économiques. En 1960, le taux de mortalité infantile était de 214 décès pour 1 000 naissances vivantes. Ce taux a diminué à 94 décès pour 1 000 naissances vivantes en 2000, puis à 52 décès pour 1 000 naissances vivantes en 2022 (Banque mondiale). Cette évolution reflète des améliorations significatives, mais la réduction reste insuffisante par rapport aux Objectifs de développement durable (ODD). Les tendances récentes montrent que les efforts doivent être intensifiés, notamment en améliorant l'accès aux soins prénatals et postnatals, en renforçant la vaccination et en luttant contre la malnutrition. Une attention particulière doit également être portée à la décentralisation des services de santé et à la lutte contre les maladies infectieuses afin d'accélérer les progrès dans la réduction de la mortalité infantile.

II. Les systèmes de santé et leur impact sur la mortalité infantile

II.1 Structure et organisation du système de santé en Côte d'Ivoire

Le système de santé en Côte d'Ivoire est structuré en trois niveaux : central, intermédiaire et périphérique. Au niveau central, le Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique est responsable de la formulation des politiques et de la coordination des actions de santé. Le niveau intermédiaire comprend les directions régionales de la santé, tandis que le niveau périphérique inclut les districts sanitaires et les centres de santé primaires. Malgré cette structure, le système de santé ivoirien fait face à des défis majeurs, notamment un financement insuffisant, une répartition inégale des ressources et un manque de personnel qualifié, en particulier dans les zones rurales.

II.2 Accessibilité et qualité des soins pour les nourrissons

L'accessibilité aux soins de santé pour les nourrissons en Côte d'Ivoire reste limitée, notamment dans les zones rurales et les quartiers défavorisés. Bien que 93 % des femmes enceintes aient accès aux soins prénataux (Banque mondiale, 2016), des disparités géographiques et économiques persistent. Les distances, le coût des soins et le manque d'infrastructures adéquates constituent toujours des barrières majeures, particulièrement en milieu rural. La qualité des soins est compromise par le manque de médicaments essentiels, d'équipements médicaux et de personnel de santé qualifié. Le paludisme, responsable de 20 % des décès d'enfants de moins de 5 ans (OMS, 2021), coûte en moyenne 10 à 15 USD par cas, un fardeau pour les familles pauvres. La couverture vaccinale en Côte d'Ivoire atteint 82 % pour le vaccin DTC3, contre 88 % au Sénégal (OMS, 2022), exposant encore les enfants à des maladies évitables. Environ 3,13 % du PIB national est consacré à la santé, un niveau relativement bas. Pour relever ces défis, la Côte d'Ivoire bénéficie du soutien d'organisations internationales. L'UNICEF a investi 15 millions USD en 2021 dans des programmes de santé infantile, et la Fondation Bill & Melinda Gates a distribué 5 millions de moustiquaires en 2020 (PNLP, 2020). Malgré ces efforts, les besoins sanitaires restent importants, soulignant la nécessité de renforcer les infrastructures, d'améliorer la gestion des ressources et d'assurer une distribution équitable des soins.

II.3 Programmes et politiques de santé publique visant à réduire la mortalité infantile

La Côte d'Ivoire a mis en place plusieurs programmes et politiques pour réduire la mortalité infantile. Parmi ceux-ci, on peut citer le Programme Élargi de Vaccination (PEV), qui vise à augmenter la couverture vaccinale contre les maladies évitables comme la rougeole, la tuberculose et la polio. Le gouvernement a également lancé des initiatives pour améliorer la santé maternelle et néonatale, telles que la gratuité des soins pour les femmes enceintes et les enfants de moins de cinq ans. Cependant, la mise en œuvre de ces programmes est souvent entravée par des problèmes de financement, de logistique et de suivi.

III. Déterminants de la mortalité infantile en Côte d'Ivoire

III.1 Facteurs médicaux et socio-économiques

Les facteurs médicaux jouent un rôle majeur dans la mortalité infantile en Côte d'Ivoire. Les principales causes de décès incluent les infections néonatales, les complications liées à la prématurité, le paludisme, les infections respiratoires aiguës et les maladies diarrhéiques. La malnutrition, en particulier la sous-alimentation et les carences en micronutriments, aggrave la vulnérabilité des nourrissons à ces maladies. Sur le plan socio-économique, la pauvreté est un déterminant clé de la mortalité infantile. Les familles pauvres ont un accès limité aux soins de santé, à l'eau potable et à l'assainissement. Le niveau d'éducation des mères influence également la survie des enfants, car les femmes éduquées sont plus susceptibles de recourir aux services de santé et d'adopter des pratiques sanitaires appropriées. Enfin, les inégalités géographiques et sociales exacerbent ces défis, avec des taux de mortalité infantile plus élevés dans les zones rurales et parmi les populations défavorisées.

III.2 Facteurs environnementaux et culturels

Les conditions environnementales en Côte d'Ivoire, telles que le manque d'accès à l'eau potable et à l'assainissement, contribuent à la propagation des maladies infectieuses. Les moustiques vecteurs du paludisme prospèrent dans les zones humides et insalubres, augmentant le risque de décès chez les nourrissons. De plus, la pollution de l'air intérieur due à l'utilisation de combustibles solides pour la cuisine expose les enfants à des infections respiratoires. Les facteurs culturels jouent également un rôle important. Certaines pratiques traditionnelles, comme le recours à des remèdes maison ou à des guérisseurs traditionnels, peuvent retarder l'accès aux soins médicaux modernes. Les croyances culturelles concernant la santé et la maladie influencent également les comportements des parents, parfois au détriment de la santé des enfants. Par exemple, certaines communautés peuvent ne pas percevoir l'importance de la vaccination ou des consultations prénatales.

IV. Analyse économique de la mortalité infantile

IV.1 Impact économique de la mortalité infantile sur le développement du pays

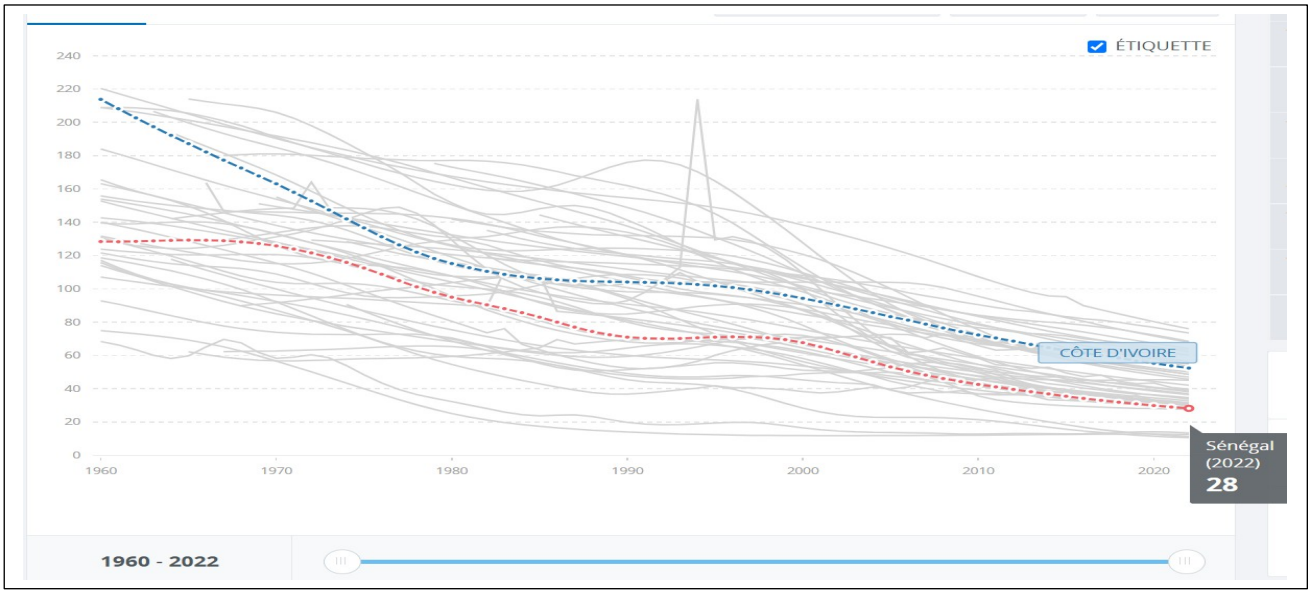
La mortalité infantile prive la Côte d'Ivoire de futurs membres actifs de la société. En 2022, le taux était de 52 décès pour 1 000 naissances vivantes (Banque mondiale, 2022). Chaque décès représente une perte potentielle de productivité, d'innovation et de contribution au développement national. Ces enfants auraient pu devenir des travailleurs qualifiés, des entrepreneurs ou des leaders économiques. À long terme, une réduction du nombre d'actifs affaiblit le marché du travail et freine le développement industriel et technologique. Les familles supportent des coûts économiques directs liés aux soins préventifs et curatifs, pouvant entraîner endettement et baisse des dépenses essentielles (éducation, alimentation). Le paludisme, principale cause de mortalité infantile, provoque 63 000 décès annuels chez les moins de 5 ans en milieu hospitalier, représentant 33 % des décès hospitaliers (Ministère de la Santé publique). Cette situation engendre des coûts pour le système de santé, limitant les ressources pour d'autres secteurs. Pour compenser ces pertes, certaines familles augmentent leur nombre d'enfants. En 2022, le taux de fécondité atteignait 4,34 enfants par femme (Banque mondiale, 2022), accentuant la pression sur les infrastructures publiques et perpétuant le cycle de la pauvreté. Cette dynamique touche particulièrement les populations ayant un accès limité aux soins, alors que 37,5 % de la population vivait sous le seuil de pauvreté en 2022 (Banque mondiale, 2022). Chaque décès infantile prive le pays d'un potentiel de croissance économique. Selon Alive & Thrive, la Côte d'Ivoire risque de perdre 630 millions de dollars par an en raison de la diminution des capacités cognitives liées à un allaitement inadéquat. De plus, la sous-nutrition infantile a causé en 2016 une perte économique estimée à 879 millions de dollars, soit 521 milliards de FCFA, correspondant à 1,83 % du PIB (Nutridata). Enfin, la perte de productivité des parents affecte le revenu familial, la consommation et l'épargne, impactant négativement l'économie nationale.

IV.2 Coût des soins et financement des politiques de santé infantile

Le système de santé ivoirien est financé par diverses sources, notamment les paiements directs des ménages, les ressources publiques provenant des recettes fiscales, les dépenses privées et la coopération internationale. En 2019, l'État a mis en place la Couverture Maladie Universelle (CMU) pour l'ensemble des populations résidant en Côte d'Ivoire, visant à améliorer l'accès aux soins de santé. Cependant, en 2020, le budget de la santé représentait seulement 3,13 % du budget total de l'État (Current health expenditure (% of GDP) - Senegal, Cote d'Ivoire | Data s. d.), reflétant des ressources limitées pour le secteur de la santé (Banque mondiale 2021°. Pour renforcer le financement des soins de santé primaires, y compris ceux destinés aux enfants, la Côte d'Ivoire a rejoint le Mécanisme de Financement Mondial (GFF). Cette initiative vise à accélérer la mise en œuvre de réformes ambitieuses et à mobiliser des financements en faveur des priorités nationales pour la santé maternelle, néonatale, infantile et des adolescents. (Global Financing Facility). Depuis avril 2011, les autorités ivoiriennes ont adopté une politique d'exemption de paiement des frais médicaux pour les usagers des établissements sanitaires publics et communautaires. En février 2012, cette mesure a été ciblée spécifiquement sur les femmes enceintes et les enfants de moins de cinq ans, offrant une gratuité des soins pour ces groupes vulnérables (Thèses.fr). En 2020, la Fondation Bill & Melinda Gates a permis de distribuer 5 millions de moustiquaires imprégnées dans les zones à risque (PNLP, 2020), contribuant ainsi à la réduction du paludisme.

V. Comparaison avec le Sénégal et perspectives de prévention pour la Côte d'Ivoire

V.1 Analyse comparative des taux de mortalité infantile entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal



SOURCE : Banque Mondial 2022 https://donnees.banquemondiale.org/indicateur/SP.DYN.IMRT.IN?contextual=region&locations=CI

La sources de toutes les données ci-dessous sont listé dans des liens mis en Annexe

INDICATEUR	Côte d'Ivoire	Sénégal	SOURCES
TAUX DE MORTALITÉ INFANTILE	52 décès/1 000 naissances	28 décès/1 000 naissances	Banque mondiale (2022)
TAUX DE MOTALITE NÉONATALE	29 décès/1 000 naissances	20 décès/1 000 naissances	Banque mondiale (2022)
TAUX DE MORTALITÉ DES MOINS DE 5 ANS	69,4 décès/1 000 naissances	37 décès/1 000 naissances	Banque mondiale (2022)

ACCÈS AUX SOINS PRÉNATALE	93 % (2016)	98 % (2019)	Banque mondiale (2022)
INCIDENCE DU PALUDISMES	260,8 pour 1 000 habitants	48, 0cas pour 1 000 habitants	Banque mondiale (2022)
SYSTÈME DE SANTÉ	Centralisé	Décentralisé	
COUVERTURE VACCINALE COMPLÈTE	DTC3 82 %	DTC3 88 %	OMS (2022)
DEPENSES DE SANTE EN % DU PIB	Environ 3,13 %	4,35 %	Banque Mondiale (2021)

Tableau 1 Analyse comparative des taux de mortalité infantile entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal

L'analyse des indicateurs de santé montre que la mortalité infantile en Côte d'Ivoire (52 décès pour 1 000 naissances vivantes) reste nettement supérieure à celle du Sénégal (28 décès). Cette tendance se retrouve pour la mortalité néonatale (29 contre 20 décès) et celle des moins de 5 ans (69,4 contre 37 décès). Plusieurs facteurs expliquent ces écarts : un accès aux soins prénatals légèrement inférieur en Côte d'Ivoire (93 % contre 98 %), une incidence du paludisme beaucoup plus élevée (260,8 contre 48 cas pour 1 000 habitants) et une couverture vaccinale complète (DTC3) plus faible (82 % contre 88 %). Enfin, le Sénégal consacre une part plus importante de son PIB à la santé (4,35 % contre 3,13 %) et bénéficie d'un système de santé décentralisé, ce qui pourrait expliquer ses meilleurs résultats sanitaire

V.2 Politiques et stratégies mises en place au Sénégal pour réduire la mortalité infantile

Le Sénégal a mis en place une politique de couverture maladie universelle (CMU) depuis 2013, permettant aux enfants de moins de 5 ans et aux femmes enceintes d'accéder gratuitement aux soins. Ce programme a permis de réduire la mortalité infantile de 30 % entre 2013 et 2023. La mise en place de relais communautaires, avec la formation de 20 000 agents de santé locaux, a joué un rôle essentiel dans la sensibilisation aux bonnes pratiques sanitaires (hygiène, allaitement, vaccination). Cette approche a augmenté l'accès aux soins de base de 60 % en zones rurales et permis une meilleure prise en charge des pathologies infantiles. Le gouvernement sénégalais a mis en place une distribution annuelle de 8 millions de moustiquaires imprégnées et des campagnes de pulvérisation intra-domiciliaire. Cette stratégie a réduit les décès liés au paludisme de 50 % chez les enfants, faisant du Sénégal un exemple régional en matière de lutte contre cette maladie

V.3 Leçons applicables à la Côte d'Ivoire

La formation et le déploiement d'agents de santé communautaires dans les zones rurales permettraient d'améliorer l'accès aux soins et de réduire la mortalité infantile. Une politique d'incitation pourrait être mise en place pour encourager les jeunes professionnels de santé à travailler dans ces zones défavorisées. La mise en place d'une gratuité ciblée pour les soins des enfants et des femmes enceintes pourrait avoir un impact significatif. Une estimation budgétaire indique un coût d'environ 100 milliards FCFA/an, nécessitant des financements innovants et un engagement accéléré de l'État et de ses partenaires. Un programme national renforcé devrait viser la distribution systématique de moustiquaires imprégnées à 100 % des ménages et l'introduction de la pulvérisation intra-domiciliaire, accompagnés de campagnes d'éducation sanitaire. L'objectif est de réduire le taux de mortalité infantile à 40 décès/1 000 naissances d'ici 2030, en s'alignant sur les ODD. Des actions clés doivent être engagées pour atteindre cette ambition.

Conclusion

La mortalité infantile en Côte d'Ivoire demeure un défi majeur de santé publique, avec un taux de 52 décès pour 1 000 naissances vivantes en 2022, bien supérieur à la moyenne mondiale de 28 décès. Cette situation s'explique par de multiples déterminants, notamment l'accès limité aux soins prénataux, une couverture vaccinale incomplète, la forte incidence du paludisme, des conditions environnementales précaires et des pratiques culturelles défavorables. L'analyse économique révèle un impact significatif sur le développement du pays, avec des pertes économiques estimées à plusieurs centaines de millions de dollars par an. La comparaison avec le Sénégal, où le taux de mortalité infantile est de 28 pour 1 000, met en lumière l'efficacité

d'un système de santé décentralisé, d'une couverture vaccinale renforcée (85 %) et d'une lutte efficace contre le paludisme. Ces résultats suggèrent des pistes d'amélioration pertinentes pour la Côte d'Ivoire. Pour réduire la mortalité infantile, il est essentiel de renforcer la décentralisation du système de santé, de former et déployer des agents de santé communautaires, et d'améliorer la couverture vaccinale. La mise en place d'une gratuité ciblée pour les soins des enfants et des femmes enceintes, couplée à des financements innovants, est également cruciale. Enfin, la lutte contre le paludisme doit être intensifiée à travers la distribution systématique de moustiquaires et des campagnes de pulvérisation intra-domiciliaire. En mettant en œuvre ces stratégies, la Côte d'Ivoire pourra espérer réduire son taux de mortalité infantile à 40 décès pour 1 000 naissances d'ici 2030, en s'alignant sur les Objectifs de développement durable. L'engagement accru de l'État, soutenu par des partenariats nationaux et internationaux, sera déterminant pour atteindre cet objectif et améliorer durablement la santé infantile dans le pays.

BIBLIOGRAPHIE

« Current health expenditure (% of GDP) - Senegal, Cote d'Ivoire | Data ». https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.CHEX.GD.ZS?locations=SN-CI (23 février 2025).

« Définition - Mortalité infantile | Insee ». https://www.insee.fr/fr/metadonnees/definition/c1922 (23 février 2025).

« Taux de mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes) - Cote d'Ivoire | Data ». https://donnees.banquemondiale.org/indicateur/SP.DYN.IMRT.IN?locations=CI (23 février 2025).

Organisation mondiale de la Santé. Rappor*Levels & Trends in Child Mortality: Report 2021*. United Nations Children's Fund (UNICEF), 2021.

NDIAYE, M., DIAKHOUMPA, M., & Mbathio, D. I. O. P. (2023). Les déterminants de la mortalité infantile au Sénégal: Une analyse économétrique. *Revue Française d'Economie et de Gestion*, *4*(10).

Antoine, P., & Mbodji, F. G. (1991). La mortalité des enfants au Sénégal: une synthèse des données. *African Population Studies*, *5*, 18-35.

Hammerslough, C. (1990). Une enquête sur la mortalité infantile et juvénile au Siné Saloum (Sénégal): Le poids des facteurs d'environnement. *Population (french edition)*, 652-656.

Sall, G., Badiane, W., Gaye, A., & Gueye, S. (2006). Mortalité des enfants au Sénégal: tendances observées, causes et perspectives. In *Enfants d'aujourd'hui, diversité des contextes, pluralité des parcours: colloque international de Dakar (10-13 décembre 2002)* (No. 11, p. 846). INED.

Banque Africaine de Développement. *Impact de la crise économique sur le secteur de la santé en Afrique de l'Oues*t. Abidjan : BAD ; 2022.

Léopold, Y. Y. (2012). Anthroponymie et santé infantile en Afrique: exemple des communautés ethniques de la Cote d'Ivoire. *European Scientific Journal*, *8*(29).

Kouassi, Y. A. G. (2021). Analyse des effets du capital santé sur la croissance économique en Côte d'Ivoire. *International Journal of Financial Accountability, Economics, Management, and Auditing*, *3*, 118-131.

Démographe, O. R. S. T. O. M., & Démographe, E. N. S. E. A. (1994). SANTÉ DE LA MÈRE ET DE L'ENFANT EN CÔTE-D'IVOIRE. *Populations du Sud et santé: parcours et horizons: Hommage à Pierre Cantrelle*, 201.

MOSSO, R. A., & GAIMARD, M. Santé et mortalité des enfants en Côte d'Ivoire: vers une réduction de l'avantage urbain?.

Adjamagbo, A., Guillaume, A., & Vimard, P. (1999). Santé maternelle et infantile en milieu Akan (Côte d'Ivoire). *Adjamagbo A., Guillaume A., N'G uessan K.(dir.), Santé de la mère et de l'enfant: exemples, africains, Paris, IRD Éditions*, 109-129.

Mosso, R. A. (2012). *Santé et mortalité des enfants en Côte d'Ivoire urbaine: vers une réduction de l'avantage urbain?* (Doctoral dissertation, Paris 5).

N'Guessan Diplo, L., Rey, J. L., Soro, B., & Coulibaly, A. (1990). La mortalite infantile et ses causes dans une sous-prefecture de Cote d'Ivoire. *Médecine tropicale*, *50*(4), 429-432.

Claude, L. E. V. Y. (1980). Influence et conséquences des facteurs socio-économiques sur la mortalité. *Population*, *35*(1), 225.

PISON G. *Pourquoi la mortalité des enfants ne baisse t-elle pas depuis une quinzaine d'années en Afrique au Sud du Sahara ? Le cas du Sénégal, un pays peu touché par le Sida. Séminaire de la Commission de l'UIESP « Nouvelles menaces sanitaires* » VIH, infections réémergentes et changements démographiques en Afrique, 2004, 25 p.

Banque mondiale. (s.d.). *Taux de mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes) - Côte d'Ivoire*.

Banque mondiale. (2010). *République de Côte d'Ivoire : Santé, Nutrition et Population - Rapport Analytique Santé Pauvreté*.

Yeo, S. (2024, 18 juillet). Actions en faveur de la santé des femmes, des enfants et des adolescents en Côte d'Ivoire. *Banque mondiale*.

Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique, Côte d'Ivoire. (2023). *Évaluation de la matrice des progrès en matière de financement de la santé : Résumé des résultats et recommandations*.

Mécanisme de Financement Mondial. (2017). *Côte d'Ivoire : Cas d'investissement*.

Desclaux, A., & Taverne, B. (2005). Coût et prise en charge du VIH/SIDA en pédiatrie à Abidjan. *Santé Publique*, 17(4), 627-641. https://shs.cairn.info/revue-sante-publique-2005-4-page-627.htm

République de Côte d'Ivoire. (s.d.). *Gratuité ciblée des soins de santé en Côte d'Ivoire*. http://www.gouv.ci/_actualite-article.php?recordID=17835

Centre de Droit de la Santé de l'Université Paris Descartes. (2019). *La couverture maladie universelle en Côte d'Ivoire : Enjeux et perspectives*.

Seuil de pauvreté en côte d'ivoire

École de droit de Sciences Po. (2023, avril). *Le droit à la santé en Côte d'Ivoire*.

Mécanisme de financement mondial (GFF). (2017, mai). *Dossier d'investissement : Côte d'Ivoire*.

N'Guessan, K. (2017). *Qualité et accessibilité aux services de soins maternels et infantiles en Côte d'Ivoire*. Thèse de doctorat, Université de Lille.

La plupart des données utilisées pour la conception de ce document proviennent du site de la banque mondiale, principalement pour l'année 2022